

レポート

家庭内の暴力と子どもの喘息・アレルギーの関係:既存の研究を整理する

科目名:【科目名】

担当教員:【担当教員名】先生

提出日:【令和 年 月 日】

学部学科:【学部・学科】

学籍番号:【学籍番号】

氏名:【氏名】

家庭内の暴力と子どもの喘息・アレルギーの関係:既存の研究を整理する

1. はじめに

家の中で暴力が起きていると、子どもの心に悪い影響が出ることはよく知られている。**【ここに、自分がこのテーマを選んだ理由や、授業で学んだことを1〜2文で書く。】**ところが近年の研究では、暴力の影響は心だけでなく、喘息などの体の病気とも関係があるかもしれないと言われ始めている。

そこで本レポートでは、次の3つの問いを立てる。1つ目は、パートナーからの暴力がある家庭で育つことは、子どもの喘息やアレルギーと関係があるのかという問いである。2つ目は、関係があるとしたら、どのような理由が考えられているのかという問いである。3つ目は、今の研究で何が分かっていて、何がまだ分かっていないのかという問いである。

これらの問いに答えるために、英語で書かれた研究論文とレビュー論文(いくつかの研究をまとめた論文)の合計5本を読み、内容を整理する。ただし、読んだ研究のほとんどは「観察研究」である。観察研究とは、人を実際に調べて関係を探る研究のことで、暴力が病気の原因だとまでは言い切れない。また、**【父親の暴力だけを調べた研究が見つからなかったことも、考察で取り上げる。】**

2. 用語の整理

親密なパートナーからの暴力(IPV)とは、夫や恋人など、親しい関係にある相手から受ける暴力のことである。身体への暴力だけでなく、心を傷つける言動や性的な暴力も含まれる。日本では「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言い方が一般的である。

【授業や参考資料での定義があれば、ここに合わせる。】

アトピー性疾患とは、アレルギーの体質と関係のある病気をまとめた呼び方である。本レポートでは、喘息、アトピー性皮膚炎(湿疹)、アレルギー性鼻結膜炎(花粉症のような症状)を指す。

また、読んだ研究の多くは、母親が自分の受けた暴力について答えたデータを使っている(Sugliaら, 2010など)。そのため、子どもが暴力を直接見たかどうかや、暴力をふるったのが父親かどうかは、研究によって扱いが違う。この点に注意して読む必要がある。

3. 先行研究の整理

先行研究を、何を調べたかによって4つに分けて整理する。なお、「～倍」という数字は、ある条件の人が、そうでない人と比べてどれくらい病気になりやすかったかを表している。

3.1 母親が受けた暴力と子どもの喘息

本レポートの問いにいちばん近いのは、アメリカの Suglia ら(2010)の研究である。この研究では、2,013 人の子どもについて、母親が子どもの父親や今のパートナーから暴力を受けていないかを、出産後、1 歳、3 歳のときに尋ねた。その結果、母親が長く暴力を受けていた子どもは、そうでない子どもに比べて、3 歳までに医師から喘息と診断された割合が約 1.8 倍であった。ただし、この結果には誤差の幅があり、関係の強さは「約 1.0 倍から 3.5 倍」の間とも考えられる。つまり、あまり強い結論とは言えない。また、この研究では、家の中が散らかっていたり、混み合っていたりすることも喘息と関係していた。住環境が悪い家庭ほど、暴力の影響が大きい傾向もあった。【「悪いことが重なるとリスクが上がる」という点を、自分の言葉で一文にまとめる。】

Bair-Merritt ら(2015)は、アメリカの低所得家庭 1,292 組を追いかけて調べた。その結果、子どもが生後 7 か月のときの母親の被害が、その後の子どもの喘息の報告につながっていた。さらに、ストレスを受けたときにストレスホルモン(コルチゾール)が増えやすい子どもでだけ、この関係がはっきり見られた。

3.2 虐待全般と喘息・アトピー

Nash ら(2022)は、イギリスの診療記録を使った研究である。子どもに虐待を受けた(疑いを含む)と記録された 183,897 人と、年齢や性別などをそろえた 621,699 人を比べた。すると、虐待を受けた人は、アトピー性疾患になる割合が 1.14 倍、喘息になる割合が 1.42 倍であった。この研究は虐待全般を調べたもので、暴力をふるった人が父親かどうかは分けていない。【虐待と DV はどう違うのかを、自分の言葉で一文で書く。】

3.3 女性本人が受けた暴力とアトピー

Nash ら(2023)も、イギリスの診療記録を使った研究である。DV を受けたと記録された女性 13,852 人と、そうでない女性 49,036 人を比べた。DV を受けた女性は、その後アトピー性疾患になる割合が 1.52 倍であった。病気ごとに見ると、喘息が 1.69 倍、アトピー性皮膚炎が 1.40 倍、アレルギー性鼻結膜炎が 1.63 倍であった。この研究の対象は子どもではなく、被害を受けた女性本人である。しかし、湿疹も含めて DV との関係を示した点で大切である。

3.4 レビューによる全体の整理

Han と Celedón(2024)のレビューは、暴力と喘息に関する最近の研究をまとめたものである。それによると、母親が暴力を受けた経験のある子どもは、喘息になる割合が 29~82% 高いという研究が 3 本あった。時間をかけて追いかけた研究でも、母親の被害と子どもの喘息やぜいぜいする呼吸との関係が報告されている。一方で、関係が見られなかった研究もある。また、このレビューは、暴力の種類ごとの影響を分けて調べるのが難しいことや、過去のことを思い出して答える際の間違い、ほかの原因の考え方が研究ごとに違うことを、研究の弱い点として挙げている。

4. 考えられる仕組み

なぜ、暴力にさらされると喘息やアレルギーになりやすくなるのだろうか。読んだ論文には、主に3つの考え方が出ていた。どれもまだ「仮説」、つまり「こうかもしれない」という段階であり、証明されたわけではない。

(1) **ストレスに反応する体の仕組みの変化。** 人の体には、ストレスを受けるとホルモンを出して対応する仕組みがある。強いストレスが長く続くと、この仕組みの働き方が変わると考えられている。Bair-Merritt ら(2015)では、ストレスでホルモンが増えやすい子どもでだけ、母親の被害と喘息の関係がはっきりしていた。つまり、ストレスに体が反応しやすい子どもほど、影響を受けやすいのかもしれない。

(2) **免疫のかたよりの変化。** 免疫とは、病気から体を守る仕組みのことである。Nash ら(2023)は、強いストレスを受けると、免疫のバランスがアレルギーを起こしやすい方向にかたより、アレルギーに関わる抗体(IgE)が増えるという先行研究を紹介している。この抗体が増えると、ほこりや花粉などに反応しやすくなる。ただし、この研究の対象は大人の女性なので、子どもにそのまま当てはまるとは限らない。

(3) **生活環境との重なり。** Suglia ら(2010)では、住環境が悪い家庭ほど、暴力と喘息の関係が強く出ていた。暴力だけでなく、住まいの問題など別のストレスが重なることで、リスクが高くなる可能性がある。【自分で調べて、家庭の経済状況など、ほかの要因を加えてもよい。】

5. 考察

ここまでの研究から、母親が受けた暴力と子どもの喘息に関係があるという報告は、いくつもあると言える。しかし、本レポートの問いに照らすと、まだ分かっていないことが4つある。

1つ目は、**父親の暴力だけを調べた研究が見つからなかったことである。** Suglia ら(2010)は、子どもの父親や今のパートナーからの暴力を尋ねているが、父親だけを取り出して分析してはいない。Han と Celedón(2024)のレビューにも、父親に限った記述は見当たらなかった。Nash ら(2023)は、暴力をふるった人が男性とは限らないが、ほとんどは男性だと述べている。そのため、「父親の暴力」と子どもの病気の関係は、今のところ直接には確かめられていないと考えられる。

2つ目は、**湿疹や食物アレルギーを調べた研究が少ないことである。** 子どもを対象にした研究は、ほとんどが喘息に集中していた。湿疹との関係を示した研究(Nash ら, 2023)は大人の女性が対象であり、子どもの湿疹や食物アレルギーについては、今回読んだ範囲では直接の証拠を確認できなかった。

3つ目は、**原因だと断定できないことである。** 読んだ研究は観察研究なので、家の経済状況や住まい、親の健康状態など、暴力と病気の両方に関わるほかの要因を、完全には取

り除けない。実際に、Han と Celedón(2024)は、ほかの要因の扱いが研究ごとに違うことや関係が見られなかった研究もあることを指摘している。

4つ目は、調べ方に限界があることである。 暴力や病気の情報は、母親の自己申告や診療記録に頼っている。記録に残らない被害や、思い出し間違いの影響を受けるおそれがある。

以上のことから、「DV が子どもの喘息の原因だ」と言い切ることはできない。しかし、関係が何度も報告されている以上、病院で子どもを診るときに、家庭内の暴力の可能性にも気づこうとする姿勢は、子どもの健康を守るために意味があるかもしれない。【ここに、自分の意見や、授業で学んだこととのつながりを書く。】

6. おわりに

本レポートでは、パートナーからの暴力と、子どもの喘息・アレルギーとの関係について、5本の論文を読んで整理した。母親が暴力を受けた家庭の子どもは、喘息になりやすいという研究がいくつかあり、その理由として、ストレスに反応する体の仕組みの変化、免疫のかたより、住まいなどほかのストレスとの重なりが考えられていた。一方で、父親の暴力だけを調べた研究や、子どもの湿疹・食物アレルギーを調べた研究は少なく、原因かどうかもまだ分かっていない。今後は、暴力をふるった人ごとに分けて調べる研究や、喘息以外のアレルギーを調べる研究が必要である。

参考文献

- 1 . Bair-Meritt , Madeline H.; Voegtline , Kristin; Ghazarian , Sharon R.; Granger , Douglas A.; Blair , Clancy; Johnson , Sara B. . Maternal intimate partner violence exposure, child cortisol reactivity and child asthma . Child Abuse & Neglect . 2015 , vol . 48 , p . 50-57 .
- 2 . Han , Yueh-Ying; Celedón , Juan C. . The effects of violence and related stress on asthma . Annals of Allergy, Asthma & Immunology . 2024 , vol . 133 , no . 6 , p . 630-640 .
- 3 . Nash , Katrina; Minhas , Sonica; Metheny , Nicholas; Gokhale , Krishna M.; Taylor , Julie; Bradbury-Jones , Caroline; Nirantharakumar , Krishnarajah; Adderley , Nicola J.; Chandan , Joht Singh . Exposure to domestic abuse and the subsequent development of atopic disease in women . The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice . 2023 , vol . 11 , no . 6 , p . 1752-1756 .
- 4 . Nash , Katrina; Minhas , Sonica; Metheny , Nicholas; Gokhale , Krishna M.; Taylor , Julie; Bradbury-Jones , Caroline; Bandyopadhyay , Siddhartha; Nirantharakumar , Krishnarajah; Chandan , Joht Singh; Adderley , Nicola J. . Association between childhood maltreatment and atopy in the UK: A population based retrospective cohort study . eClinicalMedicine . 2022 , vol . 53 , 101730 .

- 5 . Suglia , Shakira F.; Duarte , Cristiane S.; Sandel , Megan T.; Wright , Rosalind J. . Social and environmental stressors in the home and childhood asthma . Journal of Epidemiology and Community Health . 2010 , vol . 64 , no . 7 , p . 636-642 .